

Disturbi dello Spettro Autistico —

Parte 1

Percorsi nelle Disabilità · Sessione 08 · 14 aprile 2026

Questa lezione apre il grande capitolo dell'autismo: chi l'ha "scoperto", come il concetto è cambiato nei decenni, e cosa dice oggi il DSM-5. È un argomento con una storia pesante e affascinante — e capirla serve davvero per lavorare bene con le persone nello spettro.

Cos'è l'autismo (definizione di partenza)

L'**autismo** — oggi chiamato correttamente **Disturbo dello Spettro Autistico (ASD, Autism Spectrum Disorder)** — è una **sindrome comportamentale** causata da un **disordine dello sviluppo biologicamente determinato**, con esordio prima dei tre anni di vita.

Tre parole chiave da fissare subito:

- **Sindrome comportamentale** → la diagnosi si basa sull'osservazione di comportamenti, non su esami del sangue o test neurologici.
- **Biologicamente determinato** → ha radici organiche, neurologiche. **Non è una scelta, non è colpa dei genitori.**
- **Esordio precoce** → i sintomi devono essere presenti prima dei **tre anni** (anche se la diagnosi formale può arrivare molto più tardi, anche in età adulta).

Come dice la professoressa: **"L'autismo non si cura, si educa."** Questo ci dice già che il lavoro dell'educatore sociale è centrale, non marginale.

Le cause restano parzialmente sconosciute, ma c'è consenso internazionale su tre fattori che interagiscono: **neurobiologici, costituzionali e psicoambientali**. Come nel modello bio-psico-sociale che hai già visto, è sempre la triade che conta —

e l'ambiente, ancora una volta, fa la differenza sull'esordio e sulla manifestazione del disturbo.

Perché le neuroscienze c'entrano

Le neuroimmagini (le "fotografie al cervello") mostrano qualcosa di preciso: nelle persone nello spettro, **alcune aree cerebrali non si attivano come nelle persone neurotipiche, soprattutto in risposta agli stimoli sociali.**

Questo spiega, in parte, le difficoltà nell'**imitazione** — uno dei deficit più rilevanti. Pensa a come impari qualsiasi cosa: guardi qualcuno farlo, e lo replichi. **Nei bebè succede spontaneamente fin dai due mesi (guarda la lingua, il bebè la ripete).** È la base di ogni apprendimento sociale. Nelle persone nello spettro autistico questa capacità è deficitaria, il che rende necessario un lavoro educativo specifico e mirato.

La professoressa sottolinea che **imitazione e anticipazione sono i due prerequisiti fondamentali dell'apprendimento.** Quando sono carenti, bisogna costruirli intenzionalmente — non si possono dare per scontati.

L'ASD è una **disabilità permanente**: accompagna la persona per tutta la vita. Le caratteristiche però possono cambiare nel tempo — a volte migliorando, a volte peggiorando. Cosa influenza questa evoluzione? L'ambiente, la diagnosi precoce, gli interventi educativi mirati.

Qualche dato: i numeri che fanno riflettere

Contesto	Prevalenza stimata
USA (ADDM, recente)	1 su 36 bambini
Italia (7–9 anni)	1 su 77 bambini
Gran Bretagna (8 anni)	1 su 86 bambini
Danimarca/Svezia	1 su 160 bambini

Contesto	Prevalenza stimata
Inghilterra (adulti)	1 su 100
Svizzera (stima totale)	circa 80.000 persone

Negli anni '70 si parlava di 4-5 casi su 10.000. Oggi siamo a 1 su 36 negli USA. Come mai?

Non è un'epidemia. È un mix di fattori: - **Miglioramento degli strumenti diagnostici** e delle conoscenze - **Ampliamento della definizione di spettro** (che include forme prima non classificate, come la Sindrome di Asperger e l'autismo atipico) - **Maggiore sensibilizzazione** di famiglie e professionisti - **Prevalenza di genere**: l'ASD è circa **4 volte più frequente nei maschi** che nelle femmine — anche perché nelle donne i sintomi si mascherano meglio ("**camaleontismo sociale**")

La professoressa sottolinea l'importanza dell'**intervento precoce**: prima si intercettano i sintomi, maggiore è l'impatto positivo sull'evoluzione, grazie alla **plasticità cerebrale** (che funziona al meglio fino ai **20-22 anni** circa). Per questo si formano i pediatri — sono i primi a intercettare i campanelli d'allarme.

La storia: come siamo arrivati fin qui

Questa è la parte narrativa, e vale la pena studiarla bene perché spiega perché esistono ancora così tanti miti sull'autismo. Come un albero con radici storte che crescono storte — capire le radici ti aiuta a capire il presente.

1911 — Eugen Bleuler conia il termine

Lo psichiatra svizzero **Eugen Bleuler** usa per primo il termine *autismo*, dal greco **αὐτός** ("se stesso") → una persona centrata su se stessa, non sul mondo esterno.

1943 — Leo Kanner: la prima descrizione clinica

Leo Kanner (1896–1981), psichiatra austriaco, descrive **11 bambini con caratteristiche comuni** e li definisce affetti da "**autismo precoce infantile**". I sintomi osservati:

- Incapacità di relazionarsi con gli altri
- Disinteresse per gli altri bambini e per il mondo esterno
- Comportamenti ossessivi e ansia di fronte ai cambiamenti
- Interessi ristretti — a volte con **abilità cognitive e mnemoniche molto sviluppate** in quel campo specifico

Kanner ipotizza correttamente che si tratti di un **disturbo innato** (presente dalla nascita). Poi, però, commette un errore storico: da lui si recano soprattutto famiglie benestanti e professionalmente impegnate — le uniche che potevano permettersi il consulto. Kanner ne conclude erroneamente che l'autismo sia causato dai "**genitori troppo impegnati**". Questo errore metodologico lo seguirà per anni, fino al 1955 quando teorizza ufficialmente il **disturbo psicogeno**.

Attenzione: il mito del "genio autistico" nasce proprio qui. È vero che Kanner osservò abilità particolari in alcuni bambini — ma era una caratteristica di pochi, non di tutti. **Rain Man non è rappresentativo.**

1944 — Hans Asperger: una variante diversa

Hans Asperger (1906–1980), a Vienna, descrive **4 adulti con caratteristiche simili ma diverse**:

- Isolamento sociale e resistenza al cambiamento
- **Buone capacità cognitive e di memoria**
- Deficit specifici nella **pragmatica del linguaggio**

La **pragmatica linguistica** è l'uso del linguaggio nel contesto reale: non solo le parole, ma il tono, i gesti, le intenzioni comunicative, il contesto. Le persone con il profilo descritto da Asperger capiscono le parole ma non sempre "ciò che sta intorno" alla parola.

Nota storica: la ricerca di Asperger è controversa perché condotta in contesto nazista, con documentazione in gran parte andata persa. La professoressa segnala la complessità etica ma non approfondisce per mancanza di fonti solide.

Dal **DSM-5 (2013)** la diagnosi di "Sindrome di Asperger" non esiste più come categoria separata: è stata assorbita nell'unica etichetta **ASD Livello 1**. Tuttavia molte persone tengono ancora a questa identità — **in Ticino esistono ancora gruppi chiamati "Gruppi Giovani Asperger"**.

1960s — Bruno Bettelheim e la "madre frigorifero"

Bruno Bettelheim (1903–1990) è il personaggio più problematico di questa storia. Per lui l'autismo non è organico, ma una **psicosi causata dalla mancanza di amore materno**. Nasce qui il termine infame **"madre frigorifero"** — una madre fredda, distante, che non ama abbastanza il figlio.

La conseguenza pratica: i bambini venivano **tolti alle famiglie** e istituzionalizzati. Si tentava di "curare" sia il genitore che il bambino.

Questa teoria è completamente errata. Eppure ha avuto un impatto devastante per decenni.

Come è nata questa correlazione? Le ricerche recenti sulle famiglie ad alto rischio genetico mostrano che le mamme di bebè che poi riceveranno una diagnosi di ASD appaiono talvolta distaccate — non perché siano madri fredde, ma perché il bebè non risponde alle comunicazioni protocomunicative. La mamma si sente rifiutata e si ritira. **È una correlazione, non una causa. Bettelheim aveva osservato qualcosa di reale — l'aveva solo interpretato al contrario.**

I falsi miti che ne sono derivati

Questi errori storici hanno prodotto una serie di miti duri a morire:

Mito	Realtà
"Le persone autistiche hanno capacità eccezionali"	Solo alcune, come nella popolazione generale. Non è una regola.
"Se volesse potrebbe parlare"	Non è volontario — è un deficit neurologico
"L'autismo è una psicosi"	No, è un disturbo del neurosviluppo
"Si chiudono in sé stessi per scelta"	Non sanno come relazionarsi — è diverso dal sceglierlo
"Non vogliono stare con gli altri"	Non sanno come farlo, non che non lo vogliano
"I genitori sono la causa"	Smentito: stessa famiglia, più figli, solo uno con ASD

Gli anni '70 — La svolta culturale

Gli anni '70 segnano una rivoluzione. Finalmente si arriva a criteri diagnostici precisi e studi epidemiologici rigorosi.

Anno	Autore	Contributo
1964	Bernard Rimland	Autismo infantile = disturbo neurologico
1970	Ivar Lovaas	Causa biologica, intervento precoce (ABA)
1971	Eric Schopler	I genitori sono competenti, origine organica, terapia educativa
1978	Michael Rutter	Definisce con precisione i sintomi; l'autismo NON è psicosi; esordio < 3 anni
1979	Lorna Wing & Judith Gould	Smentiscono il mito dell'intelligenza sempre nella norma
1983	Lorna Wing	Definisce la triade e introduce il concetto di spettro

Lorna Wing e Judith Gould dimostrano con i dati che l'intelligenza nelle persone con autismo varia enormemente: - **60%** → gravi difficoltà intellettive - **25%** → difficoltà intellettive di grado medio - **15%** → intelligenza nella norma o superiore

Questo abbatte definitivamente l'idea del "genio autistico" come regola.

Nel DSM-III, l'autismo esce dalla categoria delle psicosi e entra nei **Disturbi Generalizzati dello Sviluppo**. Nel **DSM-IV (1994)** diventa "disturbo pervasivo dello sviluppo".

Il DSM-5 (2013): la classificazione attuale

Con il **DSM-5**, l'autismo entra nei **Disturbi del Neurosviluppo**. Le cinque diagnosi precedenti vengono unite nell'unica etichetta **Disturbo dello Spettro Autistico (ASD)**.

Un cambio di paradigma importante avviene anche con il concetto di **neurodiversità**, termine coniato da **Judith Singer** negli anni '90 e ora riconosciuto nel DSM-5. L'idea: la diversità neurologica è parte naturale della variabilità umana, non solo patologia.

La diade diagnostica

La diagnosi si basa su **due aree**:

A. Deficit persistenti della comunicazione sociale e dell'interazione sociale (3 criteri)

B. Pattern di comportamento, interessi o attività ristretti e ripetitivi (4 criteri)

Importante: il **quoziente intellettivo non rientra nella diagnosi di ASD**. Una persona con qualsiasi livello di intelligenza può ricevere una diagnosi di autismo.

I sintomi devono: 1. Essere presenti nel **periodo precoce dello sviluppo** 2. Causare una **compromissione clinicamente significativa** del funzionamento quotidiano

Un semplice tratto autistico isolato non basta per la diagnosi: servono difficoltà che impattano realmente sulla vita della persona.

I criteri diagnostici nel dettaglio

Criterio A — Deficit nella comunicazione e interazione sociale

A.1 — Deficit della reciprocità socio-emotiva

Le persone nello spettro spesso: - Non rispondono al proprio nome - Evitano o non cercano il contatto visivo - Hanno difficoltà a capire gesti, tono di voce, espressioni facciali - Non sembrano accorgersi dell'impatto dei loro comportamenti sugli altri - Possono sembrare indifferenti a chi hanno di fronte

La professoressa racconta: "Tante volte per loro chi ha di fronte è assolutamente indifferente — vogliono una cosa, ti prendono per il braccio, tu potresti essere io o chiunque altro. Il loro obiettivo è il loro bisogno. Tu sei il mezzo."

In alcuni contesti, di fronte a stress, cambiamenti o stimoli sensoriali, possono manifestarsi **comportamenti aggressivi** — non per cattiveria, ma come unica forma disponibile di risposta al sovraccarico.

A.2 — Deficit dei comportamenti comunicativi non verbali

- Difficoltà a usare o interpretare: contatto visivo, gesti, espressioni facciali, posture
- Comunicazione verbale e non verbale **scarsamente integrate**
- Esempio pratico della professoressa: "Mi puoi passare il bicchiere?" → la persona risponde "Sì" ma non lo passa. Non è provocazione: interpreta letteralmente la domanda come una domanda, non come una richiesta.

Il consiglio operativo per chi lavora con persone nello spettro: essere **diretti, chiari, precisi**. Non "mi puoi andare a prendere un caffè?" ma "vai a prendermi un caffè." Non per essere autoritari, ma per essere compresi.

A.3 — Deficit nello sviluppo, gestione e comprensione delle relazioni

- Difficoltà ad adattare il comportamento ai diversi contesti sociali
- Mancanza di gioco simbolico/immaginativo spontaneo
- Difficoltà nel fare amicizia e nel mantenere relazioni
- Mancanza di reciprocità emotiva

Queste competenze **possono essere insegnate** — ma a differenza dei bambini neurotipici, non si acquisiscono spontaneamente.

Sul linguaggio: quando manca il verbale, la persona con ASD spesso non sviluppa compensazioni gestuali spontanee. Sviluppa invece la **comunicazione motoria**: prende per mano e porta. Le persone verbali usano spesso **linguaggio ecolalico** (ripetono frasi sentite, anche dai cartoni animati, come riempitivo o per comunicare qualcosa in modo indiretto), linguaggio monocorde, o parlano a lungo di argomenti ristretti senza curarsi dell'interesse dell'interlocutore.

Criterio B — Pattern ristretti e ripetitivi

B.1 — Movimenti, uso di oggetti o eloquio stereotipati e ripetitivi

- **Stereotipie motorie**: dondolarsi, schioccare le dita, mordersi
- Allineare oggetti in modo compulsivo, farli girare
- **Ecolalia**: ripetizione immediata o differita di parole/frasi altrui (**a volte anche in lingue diverse, come nel caso raccontato in classe del ragazzo che ripeteva i numeri in tre lingue**)
- Linguaggio idiosincratico: frasi usate in modo fisso e decontestualizzato

B.2 — Insistenza nella sameness (immodificabilità)

- Stress estremo di fronte a piccoli cambiamenti
- Difficoltà nelle transizioni

- Necessità di percorrere sempre la stessa strada, mangiare sempre lo stesso cibo, fare sempre gli stessi gesti
- Schemi di pensiero rigidi

Esempio dalla professoressa: ogni anno vacanza a Disneyland, stessi spettacoli. Se anche un solo elemento cambia — è una crisi. Non è capriccio: è l'unico modo che la persona ha per gestire l'ansia in un mondo imprevedibile. La prevedibilità è il loro sistema di sicurezza.

B.3 — Interessi ristretti e fissi

- Interesse eccessivo per un argomento specifico, anomalo per intensità o profondità
- Non necessariamente funzionale: un ragazzo che conosce tutti gli orari dei treni ma non riesce a prendere il bus da solo; un altro che conta in continuazione ma non sa quantificare tre oggetti sul tavolo

Gli **interessi speciali** hanno però anche una funzione positiva: sono una fonte di piacere, di rilassamento, di "flow". Il DSM-5 stesso lo riconosce: possono diventare un punto di accesso nell'intervento educativo e professionale.

B.4 — Iper- o ipo-reattività sensoriale

Quattro categorie:

Categoria	Significato
SIRS	Ricerca attiva ripetitiva di stimoli sensoriali (toccare, muoversi)
HYPO	Risposta ridotta agli stimoli (es. alta tolleranza al dolore)
HYPER	Risposta eccessiva (es. evitare certi suoni, tessuti, luci)
EP	Percezione aumentata / enhanced perception

Dati da Greenspan e Wieder (1997) su 200 bambini in età prescolare: - 19% → iposensibilità - 39% → ipersensibilità - 39% → entrambe le condizioni

La chiave pratica: i sintomi variano enormemente in base all'ambiente. La stessa persona con la stessa diagnosi si comporta in modo molto diverso in una classe tranquilla rispetto a una mensa rumorosa con 100 bambini. L'ambiente non è neutro — è parte della diagnosi.

I tre livelli di gravità

Il DSM-5 introduce **tre livelli** basati sul grado di compromissione nelle due aree:

Livello	Caratteristiche
Livello 1 (ex "alto funzionamento" / Asperger)	Ridotta compromissione linguistica e cognitiva. Difficoltà nell'iniziare discorsi o attività in compagnia. Interessi ristretti che possono ostacolare la quotidianità.
Livello 2	Compromissione intermedia. La comunicazione verbale e non verbale presenta deficit che richiedono supporto sostanziale. Comportamenti ripetitivi evidenti e interferenti in più contesti di vita.
Livello 3	Grave compromissione. Iniziativa personale limitatissima. Comportamenti ripetitivi interferenti in qualsiasi attività. Necessità di supporto molto sostanziale in entrambe le aree.

Gli specificatori della diagnosi

Oltre ai tre livelli, la diagnosi include:

- Con/senza **compromissione intellettiva** concomitante
 - Con/senza **compromissione del linguaggio**
 - Associata a una **condizione medica o genetica** nota
 - Associata a un altro **disturbo del neurosviluppo** (es. ADHD)
-

Il concetto di neurodiversità

Il termine **neurodiversità** è stato coniato da **Judith Singer** negli anni '90. L'idea: la variazione neurologica è una parte naturale della diversità umana, non una patologia da "correggere".

Questo non nega le difficoltà reali, ma sposta la domanda: da "cosa c'è di sbagliato in questa persona?" a "come possiamo costruire ambienti e strumenti che funzionino anche per lei?". Pensala come la differenza tra "il problema è il gradino" e "il problema è la sedia a rotelle".

"Se potessi schiacciare le dita e non essere più autistica, non lo farei, perché non sarei più me stessa. L'autismo è parte di ciò che sono." —
Temple Grandin

"Non conosco nessuno che sia del tutto autistico o del tutto neurotipico. Anche Dio ha i suoi momenti autistici, è per questo che i pianeti girano." —
Jerry Newport

Il concetto di spettro — tre significati

La parola **spettro** indica tre cose distinte:

1. **Dimensionalità**: le caratteristiche dell'autismo esistono su un continuum di gravità — da molto lieve a molto grave, all'interno della popolazione clinica
2. **Continuità con la popolazione generale**: tutti abbiamo qualche tratto autistico distribuito in modo continuo. La diagnosi arriva quando questi tratti compromettono il funzionamento
3. **Eterogeneità qualitativa**: esistono diversi "tipi" di autismo, non solo diversi livelli di gravità

Come dice la professoressa: "**Quando hai visto una persona con ASD, hai visto solo UNA persona con ASD.**" Le differenze tra due persone autistiche possono essere maggiori che tra una persona autistica e una neurotipica.

Comorbidità: l'autismo raramente è solo

L'ASD coesiste spesso con altre condizioni:

Nei bambini: - ADHD (35%) - Problemi di attenzione (60-70%) - Disturbi d'ansia (40-50%) - Dislessia (15-20%) - DOP/PDA (15%)

Negli adulti: - Depressione (20-40% attuale; 70% nel corso della vita) - Disturbi d'ansia (40-50%) - DOC (44-60%) - Disturbi della personalità (70-90%) - Disturbi alimentari (20-30%)

La Fondazione ARES — risorsa ticinese

In Ticino, il punto di riferimento per famiglie e professionisti è la **Fondazione ARES (Autismo Risorse e Sviluppo)**, attiva dal 1995, con sede a Giubiasco. Offre consulenza, formazione, presa in carico individuale e parent-training. È la stessa fondazione che collabora con il corso.

Domande di orientamento allo studio

Cos'è il Disturbo dello Spettro Autistico (ASD) e quali sono le sue caratteristiche fondamentali? L'ASD (Autism Spectrum Disorder) è una sindrome comportamentale causata da un disordine dello sviluppo biologicamente determinato, con esordio prima dei tre anni di vita. Tre caratteristiche fondamentali: è una sindrome comportamentale (la diagnosi si basa sull'osservazione di comportamenti, non su esami del sangue o test neurologici); è biologicamente determinato (ha radici organiche e neurologiche, non è una scelta né colpa dei genitori); è permanente (accompagna la persona per tutta la vita, anche se le caratteristiche possono cambiare nel tempo). Le cause sono ancora parzialmente sconosciute, ma c'è consenso internazionale su tre fattori che interagiscono: neurobiologici, costituzionali e psicoambientali.

Quali sono le due aree della diade diagnostica del DSM-5 per l'ASD? Il DSM-5 basa la diagnosi di ASD su due aree: (A) Deficit persistenti della

comunicazione sociale e dell'interazione sociale, che include tre criteri — deficit della reciprocità socio-emotiva (difficoltà a rispondere alle interazioni sociali, scarso contatto visivo, difficoltà a capire gesti ed espressioni), deficit dei comportamenti comunicativi non verbali (difficoltà a usare o interpretare linguaggio non verbale, comunicazione verbale e non verbale scarsamente integrate), e deficit nello sviluppo delle relazioni (difficoltà ad adattare il comportamento ai contesti, mancanza di gioco simbolico). (B) Pattern di comportamento, interessi o attività ristretti e ripetitivi, che include quattro criteri — movimenti e linguaggio stereotipati, insistenza nella sameness (bisogno di routine), interessi ristretti e fissi, e iper- o ipo-reattività sensoriale.

Come è cambiata la visione dell'autismo nel corso della storia? Quali errori storici hanno avuto effetti più devastanti? L'autismo è stato descritto per la prima volta da Leo Kanner nel 1943 (11 bambini con "autismo precoce infantile") e da Hans Asperger nel 1944 (profilo ad alto funzionamento). L'errore più devastante è quello di Kanner stesso, che nel 1955 teorizzò il disturbo psicogeno causato dai "genitori troppo impegnati". Questo errore fu amplificato da Bruno Bettelheim negli anni '60, che inventò il termine "madre frigorifero" — una madre fredda e distante causa dell'autismo. La conseguenza pratica fu che i bambini venivano tolti alle famiglie. Questa teoria è completamente errata ma ha avuto impatto per decenni. La svolta arriva negli anni '70 con Rimland, Lovaas, Rutter e Lorna Wing, che dimostrano l'origine neurologica e abbandonano la spiegazione psicogena.

Cosa significa che l'autismo è uno "spettro"? Quali sono i tre significati del termine? Il termine spettro indica tre cose distinte: (1) Dimensionalità — le caratteristiche dell'autismo esistono su un continuum di gravità da molto lieve a molto grave; (2) Continuità con la popolazione generale — tutti abbiamo qualche tratto autistico distribuito in modo continuo, la diagnosi arriva quando questi tratti compromettono il funzionamento; (3) Eterogeneità qualitativa — esistono diversi "tipi" di autismo, non solo diversi livelli di gravità. Come sintetizza la professoressa: "Quando hai visto una persona con ASD, hai visto solo UNA persona con ASD." Le differenze tra due persone autistiche possono essere maggiori che tra una persona autistica e una neurotipica.

Quali sono i tre livelli di gravità dell'ASD nel DSM-5 e su cosa si basano?

Il DSM-5 introduce tre livelli basati sul grado di compromissione nelle due aree diagnostiche: il Livello 1 (ex "alto funzionamento"/Asperger) comporta ridotta compromissione linguistica e cognitiva, con difficoltà nell'iniziare interazioni sociali e interessi ristretti che possono ostacolare la quotidianità; il Livello 2 presenta compromissione intermedia con deficit comunicativi evidenti in più contesti e comportamenti ripetitivi interferenti; il Livello 3 è la forma grave, con iniziativa personale limitatissima, comportamenti ripetitivi interferenti in qualsiasi attività e necessità di supporto molto sostanziale in entrambe le aree.

Cos'è la neurodiversità e perché è rilevante per il lavoro educativo? Il

termine neurodiversità è stato coniato da Judith Singer negli anni '90. L'idea è che la variazione neurologica è una parte naturale della diversità umana, non solo una patologia da "correggere". Questo non nega le difficoltà reali delle persone con ASD, ma sposta la domanda: da "cosa c'è di sbagliato in questa persona?" a "come possiamo costruire ambienti e strumenti che funzionino anche per lei?". Per il lavoro educativo significa partire dai punti di forza e dagli interessi della persona, non solo dai deficit. Il DSM-5 stesso riconosce che gli interessi speciali possono diventare un punto di accesso nell'intervento educativo e professionale.

Concetti chiave

Termine	Significato
ASD	Autism Spectrum Disorder — Disturbo dello Spettro Autistico
Diade diagnostica	Le due aree diagnostiche: comunicazione sociale + comportamenti ristretti/ripetitivi
Ecolalia	Ripetizione di parole o frasi sentite (anche da media/cartoni)
Pragmatica del linguaggio	L'uso del linguaggio nel contesto: tono, intenzione, gesti — tutto ciò che va oltre le parole

Termine	Significato
Neurodiversità	Visione che considera le differenze neurologiche come naturale variabilità umana
Sameness / Immodificabilità	Bisogno intenso di routine e prevedibilità
Stereotipie	Movimenti o comportamenti ripetitivi (dondolarsi, schioccare le dita...)
Ipersensibilità / Iposensibilità	Risposta eccessiva o ridotta agli stimoli sensoriali
Intervento precoce	Avviare l'intervento il prima possibile, per sfruttare la plasticità cerebrale
Neurotipico	Chi non ha neurodivergenze
Comorbidità	Presenza simultanea di più diagnosi/condizioni
SIRS / HYPO / HYPER / EP	Le quattro categorie di risposta sensoriale nell'ASD

Collegamenti

- **Lezioni precedenti:** la triade bio-psico-sociale riappare identica (neurobiologico + costituzionale + psicoambientale). Il modello ICF è richiamato quando si parla di "impatto dei sintomi sul funzionamento quotidiano".
- **Prossima lezione (08 parte 2):** aspetti professionali — come lavorare concretamente con le persone nello spettro.
- **Da approfondire:** [Temple Grandin](#) (esempio concreto di persona con ASD ad alto funzionamento); il video "Mon petit frère de la lune" (6 min, su YouTube/Vimeo); il libro "Lo Spettro Autistico, risposte semplici" di [David Vagni](#) (gratuito online).